

# 原廠藥跟學名藥效果一樣嗎？癌症藥的特別考量

*Originator vs generic vs biosimilar in oncology: are they equivalent?*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/12 · 最後更新：2026/05/12 · 審稿：林協霆 (2026/05/12) · 主題：腫瘤藥物學名藥與生物相似藥 (Generics and biosimilars in oncology)

DOI: 10.5281/zenodo.20131218 · 此版本 10.5281/zenodo.20131219 · <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/generic-vs-originator-oncology/>

## 摘要 · ABSTRACT

小分子化療與口服 TKI 學名藥 (generic) 通常與原廠生物等效；單株抗體與生物製劑則改用「生物相似藥 (biosimilar)」概念，需更嚴格的「totality of evidence」驗證。本文整理三者差別、FDA/EMA/TFDA 審查標準、台灣健保給付邏輯、與「跨海買學名藥」的法規與風險。

「原廠藥」與「學名藥／生物相似藥」效果一樣嗎？對小分子化療與口服 TKI（如 imatinib、capecitabine），學名藥需通過「生物等效」驗證；對大分子單株抗體（如 trastuzumab、rituximab、bevacizumab），生物相似藥需通過「totality of evidence」驗證。本文用病人語言整理三者的差別、FDA/EMA/TFDA 審查標準、台灣健保給付邏輯、與「跨海買藥」的法規與風險。

## 閱讀對象

本文設定讀者為對藥品選擇有疑慮的癌友與家屬。實際處方依主治醫師判斷；本文不取代個別決策。



## 三類藥物：原廠、學名、生物相似

| 類別                       | 分子類型  | 規範                        | 範例                                            |
|--------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 原廠藥 (originator / brand) | 任何    | 完整新藥審查                    | Glivec® (imatinib)、Herceptin® (trastuzumab)   |
| 學名藥 (generic)            | 小分子   | 生物等效 (AUC、Cmax 在 80–125%) | Imatinib generic、Capecitabine generic         |
| 生物相似藥 (biosimilar)       | 大分子蛋白 | Totality of evidence      | Herzuma®, Ontruzant® (trastuzumab biosimilar) |

## 學名藥的審查標準（小分子）

| 試驗      | 要求                     |
|---------|------------------------|
| 化學結構    | 完全相同（活性成分）             |
| 劑型、給藥途徑 | 相同                     |
| 生物等效    | AUC、Cmax 落在原廠的 80–125% |
| 賦形劑     | 可不同（不應影響療效）            |
| 製劑 GMP  | 同等品質要求                 |

例：imatinib 學名藥多家上市；capecitabine 學名藥眾多；erlotinib、gefitinib 多廠牌。

## 生物相似藥的審查（大分子）

「Totality of evidence」——層層比對：

| 層級             | 比對                       |
|----------------|--------------------------|
| 1. 物理化學        | 蛋白質結構、糖基化、摺疊、聚合體         |
| 2. 功能 / 體外     | 結合親和力、ADCC、CDC 等         |
| 3. 動物          | PK、毒性                    |
| 4. PK / PD（人類） | 健康志願者或病人                 |
| 5. 臨床對等性試驗     | 通常與原廠在敏感族群做 RCT，看療效與安全等效 |
| 6. 免疫原性        | anti-drug antibody（ADA）  |

已上市的腫瘤 biosimilar：

| 原廠                      | 生物相似藥（部分）                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Trastuzumab（Herceptin）  | Herzuma、Ontruzant、Trazimera、Kanjinti、Ogivri 等 |
| Rituximab（MabThera）     | Truxima、Rixathon、Ruxience 等                   |
| Bevacizumab（Avastin）    | Mvasi、Zirabev、Aybintio 等                      |
| Filgrastim（Neupogen）    | Zarxio、Filgrastim-sndz 等                      |
| Pegfilgrastim（Neulasta） | Fulphila、Ziextenzo、Lapelga 等                  |
| Cetuximab（Erbix）        | Erbix 生物相似藥（部分國家）                             |

## 證據：生物相似藥真的等效嗎？

| 試驗                                            | 結論                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Heritage</b> (HERA biosimilar trastuzumab) | 等效於原廠                             |
| <b>PF-05280014</b> (trastuzumab biosimilar)   | 等效                                |
| <b>CT-P10</b> (rituximab biosimilar)          | 等效於原廠                             |
| <b>NOR-SWITCH</b>                             | 多種 biosimilar 切換的真實世界研究 → 無臨床顯著差異 |

多國上市後追蹤：累積 10+ 年的真實世界數據支持互換性與等效性。

## 台灣健保給付邏輯

| 情境             | 處理                                |
|----------------|-----------------------------------|
| 健保藥品給付項目含「該成分」 | 醫院依採購選擇（原廠 / 學名 / biosimilar）     |
| 原廠專利期滿後        | 學名藥 / biosimilar 進入；健保多選擇成本效益佳的版本 |
| 病人偏好特定廠牌       | 部分情境可自費差價選擇                       |
| 健保預算考量         | 鼓勵 biosimilar 使用以降低總體支出           |

## 哪些情境要特別小心？

| 情境         | 注意                       |
|------------|--------------------------|
| 過敏 / 賦形劑反應 | 換廠牌可能改變過敏風險              |
| 長期穩定治療中切換  | 多數安全，但需密切監測前 3 個月        |
| 罕見免疫原性反應   | biosimilar 切換需追蹤 ADA（少見） |
| 跨海購藥       | 來源、冷鏈、真偽風險高              |

## 跨海購藥：法規與風險

### 合法路徑

依《藥事法》第 39 條，個人病人用量（< 6 個月）可申請 TFDA 個人輸入許可：

- 主治醫師處方
- 個人自用聲明

- TFDA 核可後可進口

## 風險

| 風險     | 說明                   |
|--------|----------------------|
| 來源真偽   | 印度有合格與偽藥廠並存          |
| 冷鏈     | 多數蛋白質藥需 2-8°C，跨海運送風險 |
| 監測困難   | 醫師對「不知道是什麼版本」的藥無法評估  |
| 保險不核退  | 多數保險條款不認跨海購藥         |
| 進口偽藥法律 | 個人用量內合法；商業販售違法       |

## 較安全的跨海管道

- 透過合格藥商或藥廠官方管道
- 香港或新加坡的合格藥房（運輸距離短）
- 與主治醫師討論監測計畫
- 保留所有收據與來源證明

## 適用對象 / 不適用對象

### 本文適用

- 對藥品選擇有疑慮的癌友與家屬
- 想了解學名藥 / biosimilar 法規的同業
- 第一線住院醫師、家醫科衛教

### 本文不適用

- 取代主治醫師對個別處方的判斷
- 偽藥辨識（需專業藥商或藥師）

## 副作用 / 風險揭露

### 一般原則

- 學名藥 / biosimilar 的副作用譜應與原廠相近
- 切換廠牌的前 3 個月建議密切監測
- 不良事件依《藥害救濟法》與不良反應通報處理

## 主要禁忌

- 對該成分已知過敏
- 賦形劑過敏（不同廠牌可能不同）
- 跨海購買來源不明的藥

## 該問藥師 / 醫師的問題

---

### 我用的是原廠、學名藥還是 biosimilar？

多數情境是健保決定，但有知情權。

### 切換廠牌對我有影響嗎？

多數沒有，但若有持續穩定治療中可詢問。

### 學名藥的療效監測指標跟原廠一樣嗎？

通常一樣。

### 我可以自費選原廠嗎？差價多少？

視藥物與醫院。

### 跨海買的話法律與風險？

請與主治醫師、藥師、TFDA 諮詢。



## 參考文獻

---

1. US Food and Drug Administration. **Biosimilar and Interchangeable Biologics: More Treatment Choices**. FDA. [fda.gov/biosimilars](https://www.fda.gov/biosimilars)
2. Rugo HS, et al. **Effect of a Proposed Trastuzumab Biosimilar Compared With Trastuzumab on Overall Response Rate in Patients With ERBB2 (HER2)-Positive Metastatic Breast Cancer (Heritage)**. *JAMA*. 2017;317(1):37–47. doi:10.1001/jama.2016.18305
3. Kim WS, et al. **Efficacy, pharmacokinetics, and safety of the biosimilar CT-P10 compared with rituximab in patients with previously untreated advanced-stage follicular lymphoma: a randomised, double-blind, parallel-group, non-inferiority phase 3 trial**. *Lancet Haematol*. 2017;4(8):e362–e373. doi:10.1016/S2352-3026(17)30106-0
4. Cohen HP, et al. **Switching Reference Medicines to Biosimilars: A Systematic Literature Review of Clinical Outcomes**. *Drugs*. 2018;78(4):463–478. doi:10.1007/s40265-018-0881-y
5. European Medicines Agency. **Biosimilars in the EU — Information guide for healthcare professionals**. [ema.europa.eu](https://www.ema.europa.eu)
6. 衛生福利部食品藥物管理署. **生物相似性藥品查驗登記審查基準**. TFDA. [fda.gov.tw](https://www.fda.gov.tw)

引用整理協力：FDA / EMA / TFDA biosimilar 指引、Heritage（JAMA 2017）、CT-P10（Lancet Haematol 2017）、Cohen 2018 switching systematic review (2026/05/12)。

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/generic-vs-originator-oncology/>

CITATION 林協霆. 原廠藥跟學名藥效果一樣嗎？癌症藥的特別考量. 林協霆 · 臨床筆記. 2026/05/12. doi:10.5281/zenodo.20131218

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](#) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN／ASCO／ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。